FACULTÉ DE MÉDECINE DE LAGHOUAT · 6ÈME ANNÉE MÉDECINE · 2026/2027

Mésothéliome pleural malin

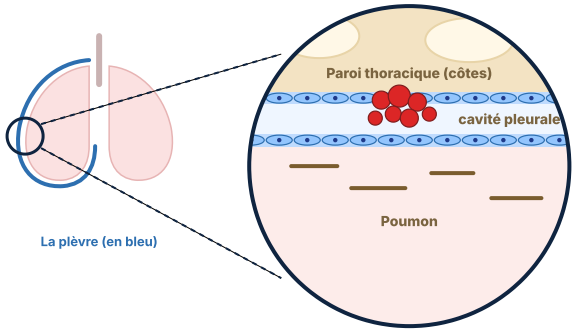
chez un ancien calorifugeur exposé à l'amiante — cas clinique évolutif

Présenté par **BABAAISSA Zakaria** · Encadrement : **Dr. S. Labouabi**
Module de médecine du travail

1. Définition et épidémiologie
2. Secteurs à risque en Algérie
3. Physiopathologie et rappel de la plèvre
4. Clinique et diagnostic
5. Prise en charge thérapeutique
6. Cadre médico-légal en Algérie 🇩🇿
7. Mésothéliome ou asbestose ?
8. Cas clinique évolutif

Résumé du cours

1. Définition



La **plèvre** est une fine membrane à deux feuillets qui enveloppe le poumon : **pariétal** (contre la paroi) et **viscéral** (sur le poumon).

🔍 Elle est tapissée d'une seule couche de **cellules mésothéliales** (le **mésothélium**), cellules plates qui produisent le liquide de glissement.

Les **fibres d'amiante** inhalées migrent jusqu'à la plèvre et s'y fichent.

Le **mésothéliome** est une **tumeur maligne primitive**, très agressive, née de ces **cellules mésothéliales** (plèvre ≈ 90 %, plus rarement péritoine ou péricarde).

2. Étiologie

>80%

des cas : exposition à l'amiante

L'**exposition aux fibres d'amiante** est le facteur de risque **majeur et avéré** (plus de 80 % des cas).

🚬 Le **tabac n'est pas** un facteur inducteur du mésothéliome (contrairement au cancer bronchopulmonaire), mais il aggrave les autres atteintes respiratoires.

3. Latence



Caractéristique majeure : une **très longue latence**, temps écoulé entre la **première exposition** et l'apparition de la maladie, de **20 à 50 ans**.

La maladie survient souvent **après la retraite** : l'interrogatoire professionnel doit remonter toute la carrière.

4. Secteurs professionnels à risque en Algérie

Fibrociment

Inhalation de poussières de fibrociment

Bâtiment

Démolition = libération de fibres

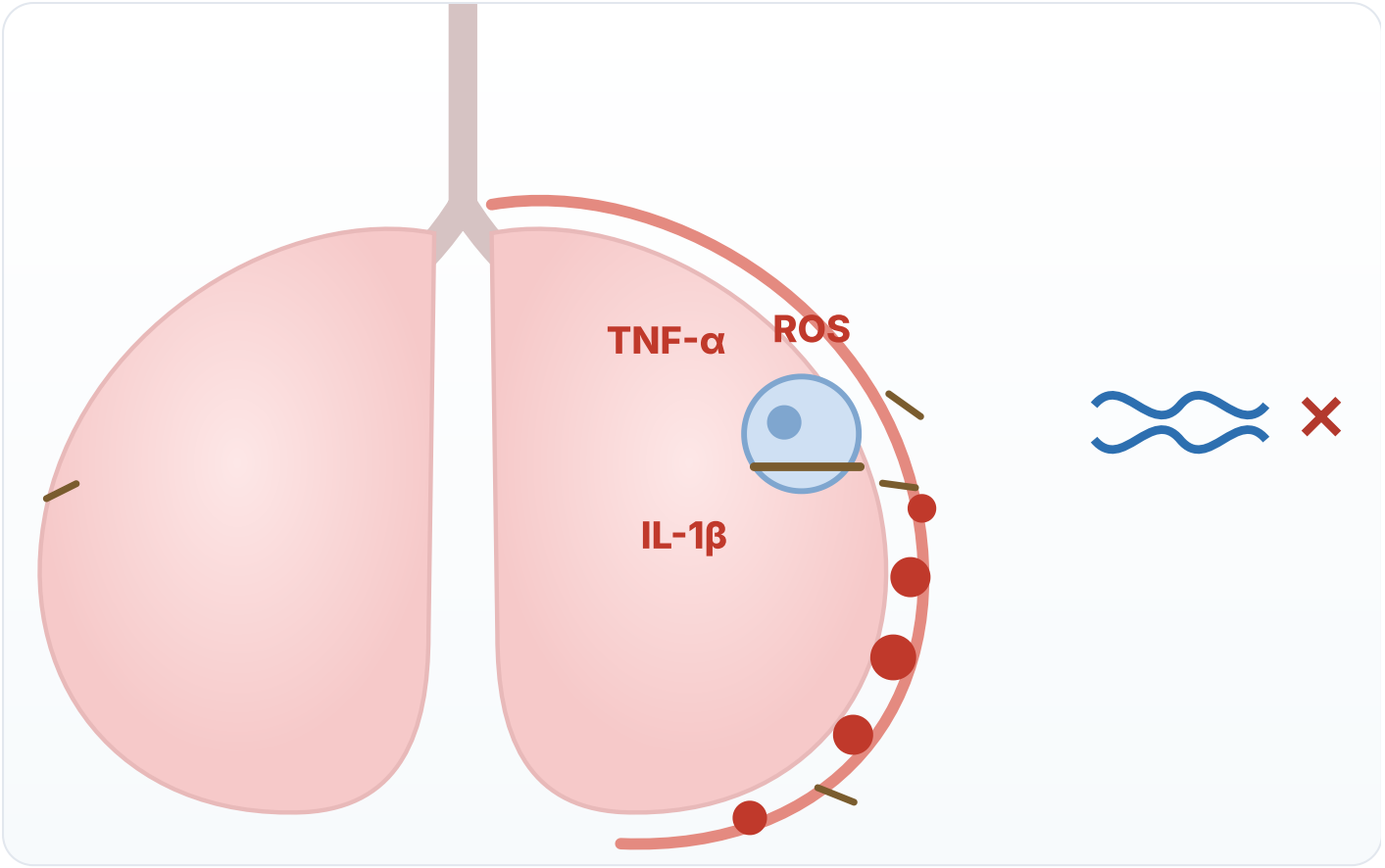
Mécanique automobile

Poussière de freins et d'embrayages

Chantiers navals

Isolation thermique, calorifugeage et chaudronnerie

5. Physiopathologie



1 **Inhalation**

Micro-fibres d'amiante ; **amphiboles** plus agressives que le chrysotile

2 **Migration**

Les fibres les plus fines gagnent la **plèvre périphérique**

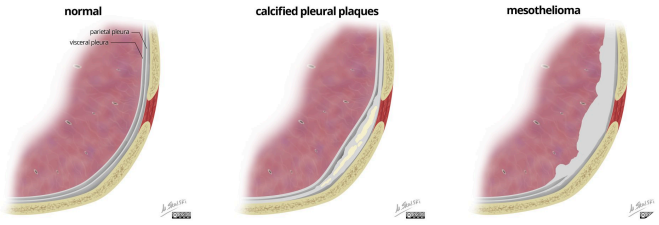
3 **Agression chronique**

Irritation mécanique chronique, **stress oxydatif**, **inflammation locale persistante**

4 **Transformation maligne**

Lésions directes de l'ADN → transformation maligne des cellules mésothéliales

6. La plèvre : plaques pleurales ou mésothéliome ?



Illustrations : M. Skalski — Radiopaedia.org (CC BY-NC-ND)

🟢 **Plèvre normale** : deux feuillets fins, **pariétal** (contre la paroi) et **viscéral** (sur le poumon).

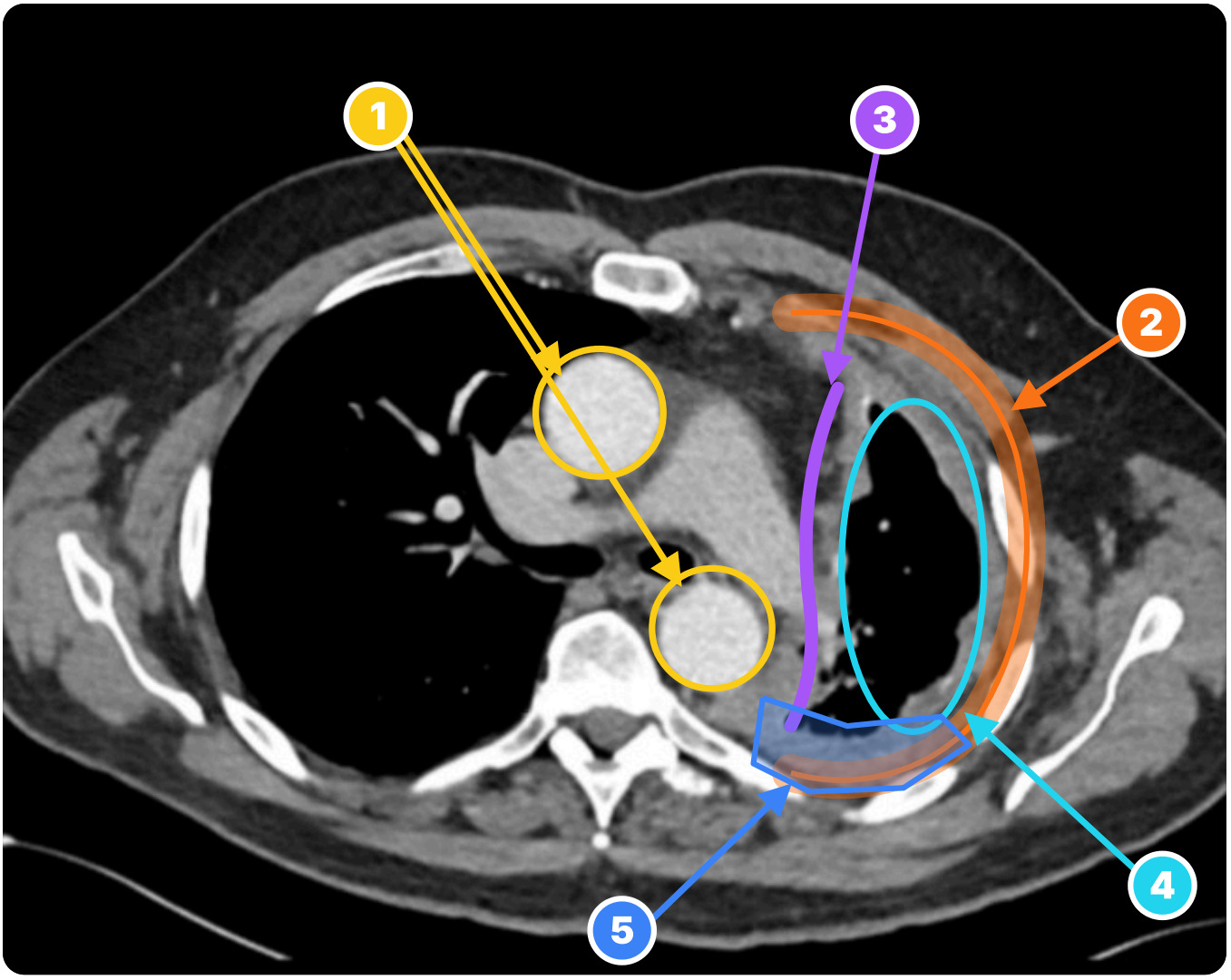
🟡 **Plaques pleurales — BÉNIGNES** : fibrose localisée, ± calcifiée, de la plèvre **pariétale**. Asymptomatiques, marqueur d'exposition (≥ 20 ans), ne dégénèrent pas.

🔴 **Mésothéliome — MALIN** : tumeur du mésothélium qui envahit la plèvre. Douleur, dyspnée, épanchement ; latence 30 à 50 ans.

1. Épaississement **nodulaire, irrégulier** (bourgeons)
2. Épaississement **continu et épais (> 1 cm)** qui engaine le poumon : plèvre « en cuirasse »
3. Poumon **englobé et rétracté** → ce sont ces signes qu'on retrouve au scanner ➜

7. Ce que montre le scanner

LECTURE : LES MÊMES SIGNES AU SCANNER (COUPE N° 22)



1 **Aorte ascendante et descendante rehaussées** : il s'agit d'une TDM **injectée**.

2 **Épaississement pleural gauche circonférentiel, irrégulier et nodulaire** (> 1 cm), plèvre « en cuirasse ».

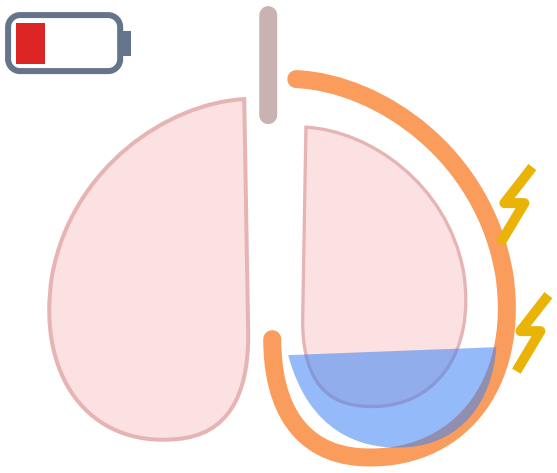
3 **Atteinte de la plèvre médiastinale**, au contact du médiastin.

4 **Poumon gauche résiduel réduit** : rétraction de l'hémithorax gauche.

5 **Épanchement pleural (pleurésie)** associé, collection déclive postérieure — souvent abondant au moment du diagnostic.

6 **Signes d'exposition à l'amiante associés** : plaques pleurales (parfois calcifiées), témoins de l'exposition passée — présence inconstante, à rechercher sur l'ensemble des coupes.

8. Ce qui explique les signes cliniques



🫁 **Dyspnée** (le plus fréquent).
Pourquoi ? L'**épanchement** et la **plèvre épaissie et rigide** compriment le poumon et l'empêchent de se dilater à l'inspiration.

⚡ **Douleur thoracique** unilatérale, sourde, irradiant à l'épaule ou au dos.
Pourquoi ? L'**invasion tumorale** et l'inflammation irritent les nerfs de la paroi, de la plèvre pariétale et du diaphragme.

⚖️ **Altération de l'état général** (amaigrissement, fatigue, anorexie).
Pourquoi ? Syndrome inflammatoire tumoral, dépense énergétique du cancer et gêne respiratoire.

Signes peu spécifiques : c'est le **contexte d'exposition** qui doit faire penser au mésothéliome.

9. Diagnostic de certitude

1. **Imagerie : TDM thoracique injectée**
2. **Ponction pleurale : cytologie souvent négative**
3. **Biopsies pleurales, idéalement par thoracoscopie**
4. **Diagnostic histologique = certitude ✓**

Formes histologiques



✓ Épithélioïde : pronostic plus favorable

⚠ Sarcomatoïde : très agressive

10. Prise en charge thérapeutique

RCP
approche pluridisciplinaire

Chimiothérapie systémique

Sel de platine (**cisplatine**) + antifolate (**pémétrexed**)

Immunothérapie

De plus en plus intégrée : **double blocage** par anticorps monoclonaux

Chirurgie · Radiothérapie

Discutées **au cas par cas**, souvent à visée palliative

Soins de support

Pleurodèse au talc des épanchements récidivants, prise en charge majeure de la **douleur**

⚖️ 11. Cadre médico-légal en Algérie 🇩🇿



En Algérie, le mésothéliome est le **modèle type du cancer d'origine professionnelle**, reconnu au titre du **tableau n° 30** (CNAS).

Délai de prise en charge : 30 ans après la cessation de l'exposition, pour s'adapter à la longue latence de la maladie.

12. Tableau n° 30 des maladies professionnelles

🔴 Le **mésothéliome malin primitif** figure au tableau n° 30

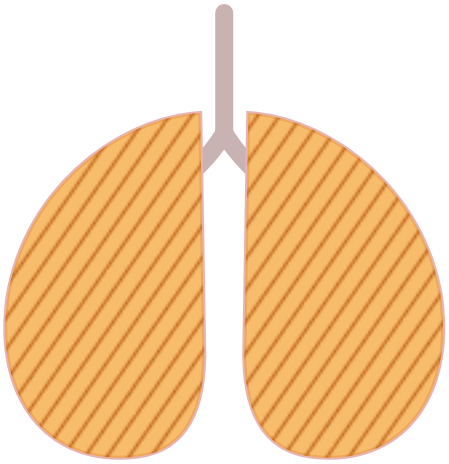
⏳ Délai de prise en charge : **30 ans**

🛠️ Le **calorifugeage** figure dans la liste indicative des travaux

Tableau N° 30 : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante

DÉSIGNATION DES MALADIES	DPC	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
1) Asbestose : – Fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. – *Complications* : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.	**15 ans**	**Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :** • Extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. • Manipulation et utilisation de l'amiante brut. • Manipulation, application, destruction et élimination de produits d'amiante ou à base d'amiante : amiante projetée, calorifugeage au moyen de produits d'amiante, maintenance et entretien de matériels, démolition. • Déflocage.
2) Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : – pleurésie exsudative ; – plaques pleurales ± calcifiées bilatérales, pariétales, diaphragmatiques ou médiastinales ; – plaques péricardiques ; – épaississements pleuraux avec ou sans irrégularités diaphragmatiques.	**15 ans**	
3) Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.	**30 ans**	
4) Autres tumeurs pleurales primitives.	**30 ans**	
5) Cancers broncho-pulmonaires primitifs.	**30 ans**	

13. Asbestose ou mésothéliome ?



🟠 **Asbestose = fibrose du tissu pulmonaire**

🔴 **Mésothéliome = cancer de la membrane (plèvre)**

	ASBESTOSE	MÉSOTHÉLIOME
Nature	Non cancéreuse : fibrose (cicatrisation) diffuse	**Cancer** rare et très agressif
Siège	Alvéoles, **parenchyme**	**Plèvre** (≈ 90 %), péritoine, péricarde
Signes	Dyspnée d'effort, toux sèche	Douleur, dyspnée, épanchement, amaigrissement
Évolution	Chronique, invalidante ; ↑ risque de cancer du poumon	Pronostic **très sombre** ; latence 30 à 40 ans

MÉSOTHÉLIOME PLEURAL MALIN

Cas clinique



B. Abdelkader, homme de **67 ans** · ancien calorifugeur, retraité

Motif de consultation

- Dyspnée progressivement croissante depuis **3 mois**
- Douleur thoracique **gauche**
- Amaigrissement de **6 kg**

Antécédents

- HTA traitée
- Tabagisme : **12 paquets-années**, sevré depuis 18 ans

Examen clinique

- FR **23/min** · SpO_2 **93 %** (air ambiant)
- Diminution du murmure vésiculaire à la **base gauche**
- Matité à la **base gauche**

QCM 1 / 10 · DIAGNOSTICS À ÉVOQUER

Homme de 67 ans, **ancien calorifugeur**, ex-fumeur : **dyspnée** progressive, **douleur thoracique gauche**, **amaigrissement de 6 kg** et **syndrome d'épanchement pleural gauche**.

Devant ce tableau clinique, quels sont les diagnostics à évoquer ?

A Cancer bronchopulmonaire

VRAI : À évoquer : chez un ancien exposé à l'amiante et ex-fumeur, un cancer bronchopulmonaire peut se révéler par une pleurésie (envahissement ou métastases pleurales). Amiante et tabac y agissent en synergie multiplicative.

B Mésothéliome pleural malin

VRAI : Diagnostic à évoquer en premier : ancien calorifugeur, douleur thoracique persistante, dyspnée par épanchement, amaigrissement. C'est le cancer « sentinelle » de l'exposition à l'amiante.

C Pleurésie métastatique d'un autre cancer primitif

VRAI : À évoquer : les métastases pleurales (poumon, sein, ovaire, digestif, lymphome) sont la première cause de pleurésie maligne. Seules l'histologie et l'immunohistochimie les distinguent d'un mésothéliome.

D Tuberculose pleurale (pleurésie tuberculeuse)

VRAI : À évoquer systématiquement en Algérie, pays d'endémie : la tuberculose pleurale donne un exsudat lymphocytaire avec altération de l'état général. Recherche de BK, dosage de l'ADA, histologie à la recherche de granulomes.

E Une insuffisance cardiaque gauche

FAUX : Peu probable ici : l'insuffisance cardiaque donne plutôt un transsudat, souvent bilatéral, avec orthopnée et signes congestifs. Elle n'explique ni la douleur thoracique persistante ni l'amaigrissement de 6 kg.

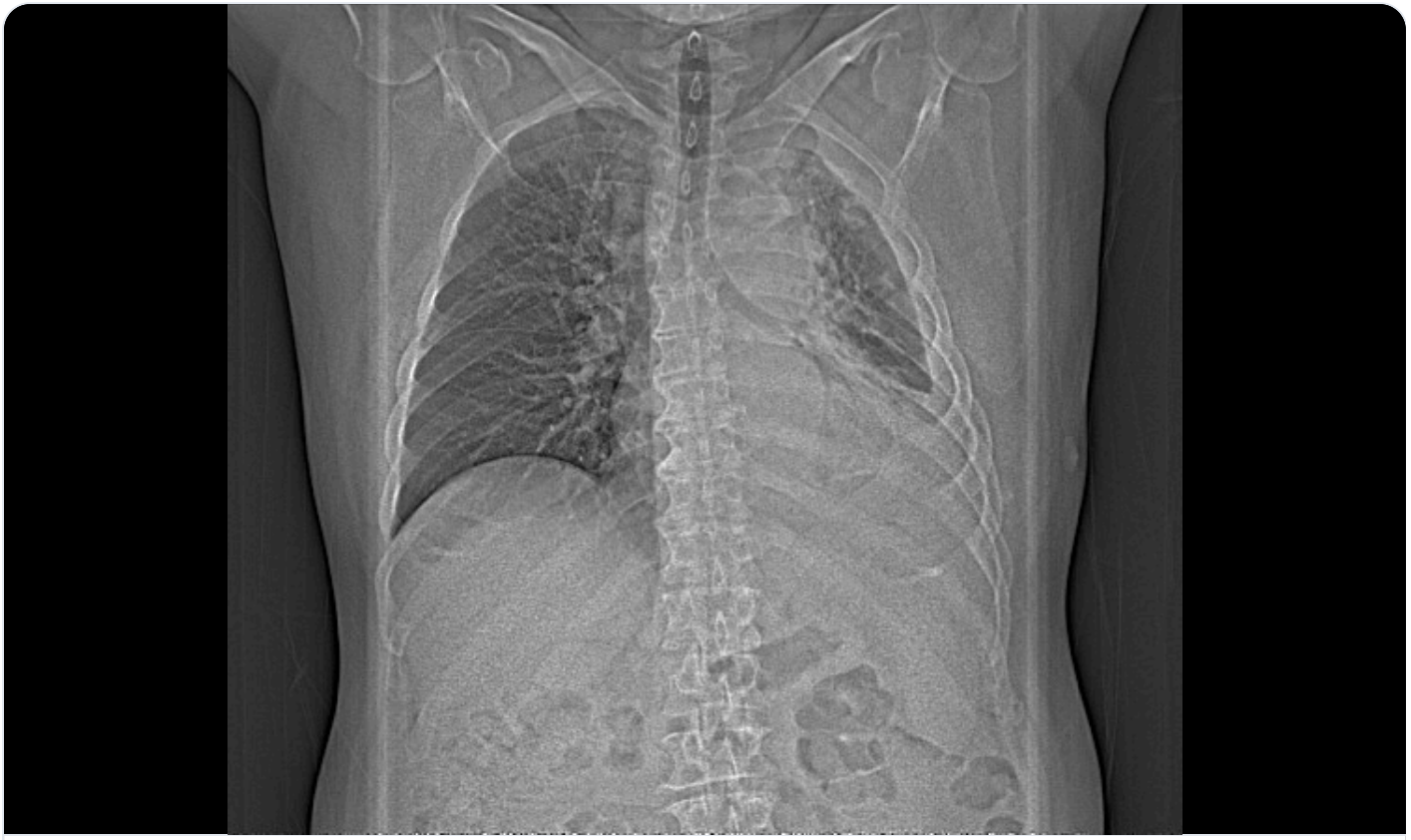
Réponses justes : A, B, C, D

À retenir : Pleurésie unilatérale avec altération de l'état général chez un ancien exposé : penser mésothéliome, cancer bronchopulmonaire, métastase et tuberculose. L'histologie tranchera.

Références : Scherpereel A. et al., ERS/ESTS/EACTS/ESTRO, Eur Respir J 2020.

QCM 2 / 10 · PRÉSENTATION CLINIQUE

Une **radiographie thoracique** a été réalisée.



Téléthorax de face

Concernant la présentation clinique, quelles propositions sont exactes ?

A Une latence de plus de vingt ans après la dernière exposition à l'amiante rend moins probable un mésothéliome lié au travail, comparativement à une tumeur survenant dans les dix premières années.

FAUX : La latence du mésothéliome est très longue : 20 à 50 ans après le début de l'exposition. Un long délai est donc l'argument typique EN FAVEUR du lien ; c'est une tumeur apparue dans les dix premières années qui serait inhabituelle.

B Une radiographie thoracique montrant un épanchement pleural unilatéral permet de différencier un mésothéliome d'une métastase pleurale.

FAUX : Un épanchement unilatéral n'a aucune spécificité : métastases pleurales, lymphome, tuberculose, pleurésie asbestosique bénigne. Ni la radiographie ni le scanner ne séparent mésothéliome et métastase : seule l'histologie le permet.

C La découverte d'un épanchement pleural chez un ancien calorifugeur justifie une enquête d'exposition même si le patient ne rapporte spontanément aucun contact avec l'amiante.

VRAI : Le calorifugeage est l'un des métiers les plus exposés (isolants thermiques anciens à base d'amiante). Le patient ignore souvent la composition des matériaux : l'interrogatoire professionnel doit être actif et systématique (périodes, postes, tâches, protections).

D Chez un patient ayant fumé et travaillé au contact d'isolants anciens, la quantification du tabagisme permet de hiérarchiser les deux expositions dans l'attribution causale du mésothéliome.

FAUX : Le tabac n'est PAS un facteur de risque du mésothéliome : il n'entre pas dans l'attribution causale. Les paquets-années servent pour le cancer bronchopulmonaire, où tabac et amiante agissent en synergie.

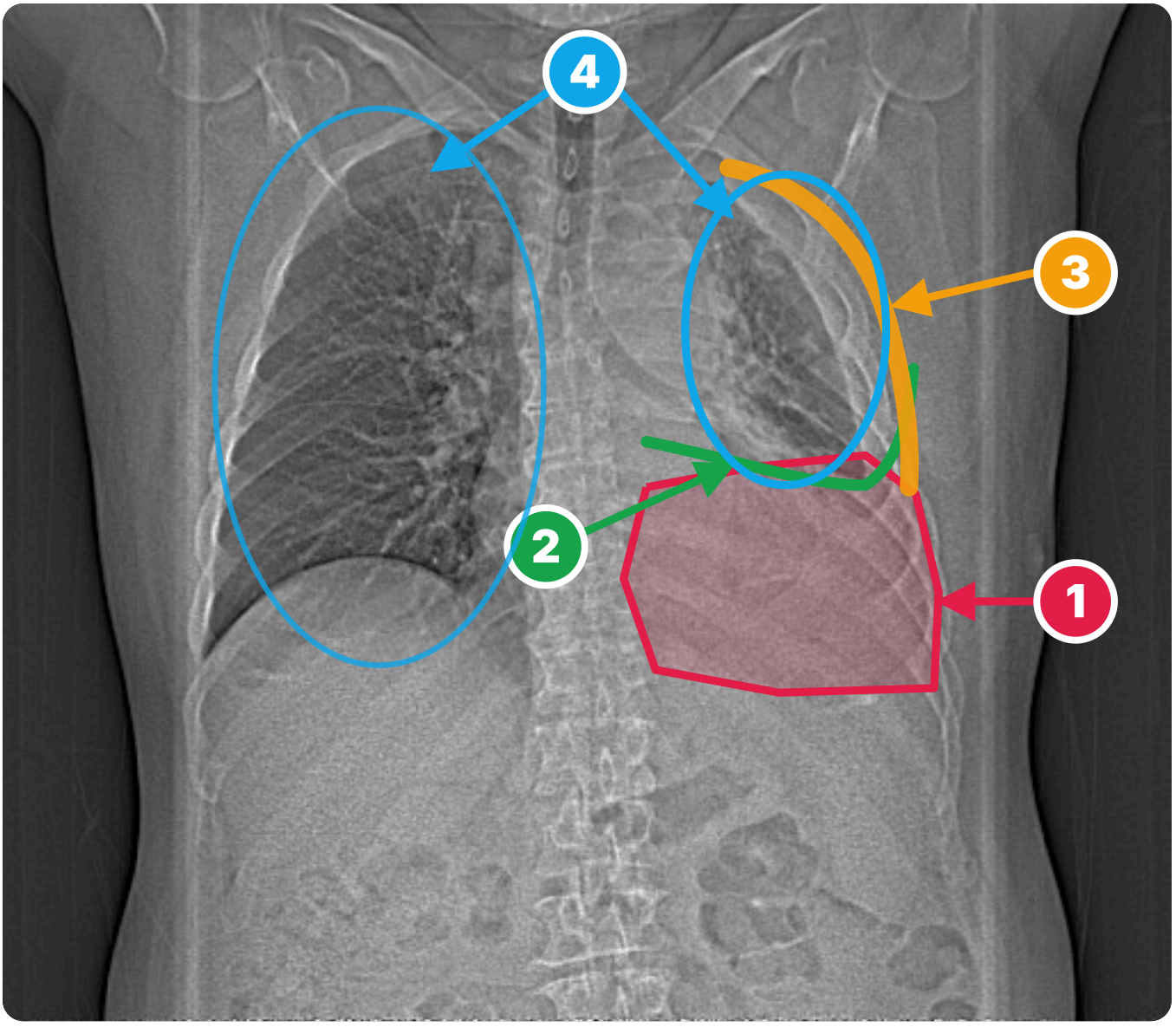
E L'absence de plaques pleurales ou de signes radiologiques d'asbestose rend peu probable l'imputabilité d'un mésothéliome à une exposition professionnelle à l'amiante.

FAUX : Plaques et asbestose sont des marqueurs d'exposition inconstants : beaucoup de mésothéliomes surviennent sans eux, y compris après des expositions faibles ou brèves. Leur absence n'exclut ni l'exposition ni l'imputabilité.

Réponses justes : C

À retenir : Latence longue = argument en faveur. Tabac = aucun rôle dans le mésothéliome. Toujours rechercher activement l'exposition.

LECTURE DU TÉLÉTHORAX



1 **Opacité pleurale gauche** dense, homogène, basale, avec comblement du cul-de-sac costodiaphragmatique gauche.

2 **Ligne de Damoiseau** : limite supérieure de l'épanchement, concave en haut, qui remonte en dehors vers l'aisselle.

3 **Épaississement pleural lobulé** le long de la paroi latérale gauche.

4 **Rétraction de l'hémithorax gauche** : le poumon gauche aéré est bien plus petit que le droit (perte de volume), sans refoulement du médiastin.

Références : CIRC, Monographies vol. 100C · ERS 2020.

Un **scanner thoracique** a été réalisé. Faites défiler les coupes pour l'analyser.

Concernant le scanner thoracique, quelles propositions sont exactes ?

A Dans ce cas, la TDM est faite sans injection.

FAUX : Les coupes montrent un rehaussement franc de l'aorte, des artères pulmonaires et des cavités cardiaques : c'est une TDM INJECTÉE. L'injection est recommandée pour l'exploration pleurale (rehaussement des épaississements, distinction liquide/tissu, extension médiastinale).

B L'association d'un épaississement pleural nodulaire circonférentiel et d'une réduction du volume de l'hémithorax est évocatrice d'un mésothéliome pleural malin, sans être spécifique.

VRAI : Épaississement circonférentiel, nodulaire, de plus de 1 cm, atteignant la plèvre médiastinale (critères de Leung) et rétraction de l'hémithorax sont très évocateurs. Mais des métastases pleurales peuvent réaliser le même aspect.

C L'effacement des plans graisseux entre l'épaississement pleural et l'aorte thoracique ou le péricarde fait suspecter une extension locale, sans démontrer à lui seul une invasion histologique de ces structures.

VRAI : La perte du liseré graisseux fait suspecter un envahissement, mais peut aussi résulter d'un simple accolement, d'un effet de volume partiel ou d'une inflammation. L'invasion ne se prouve que par l'histologie ou l'exploration chirurgicale.

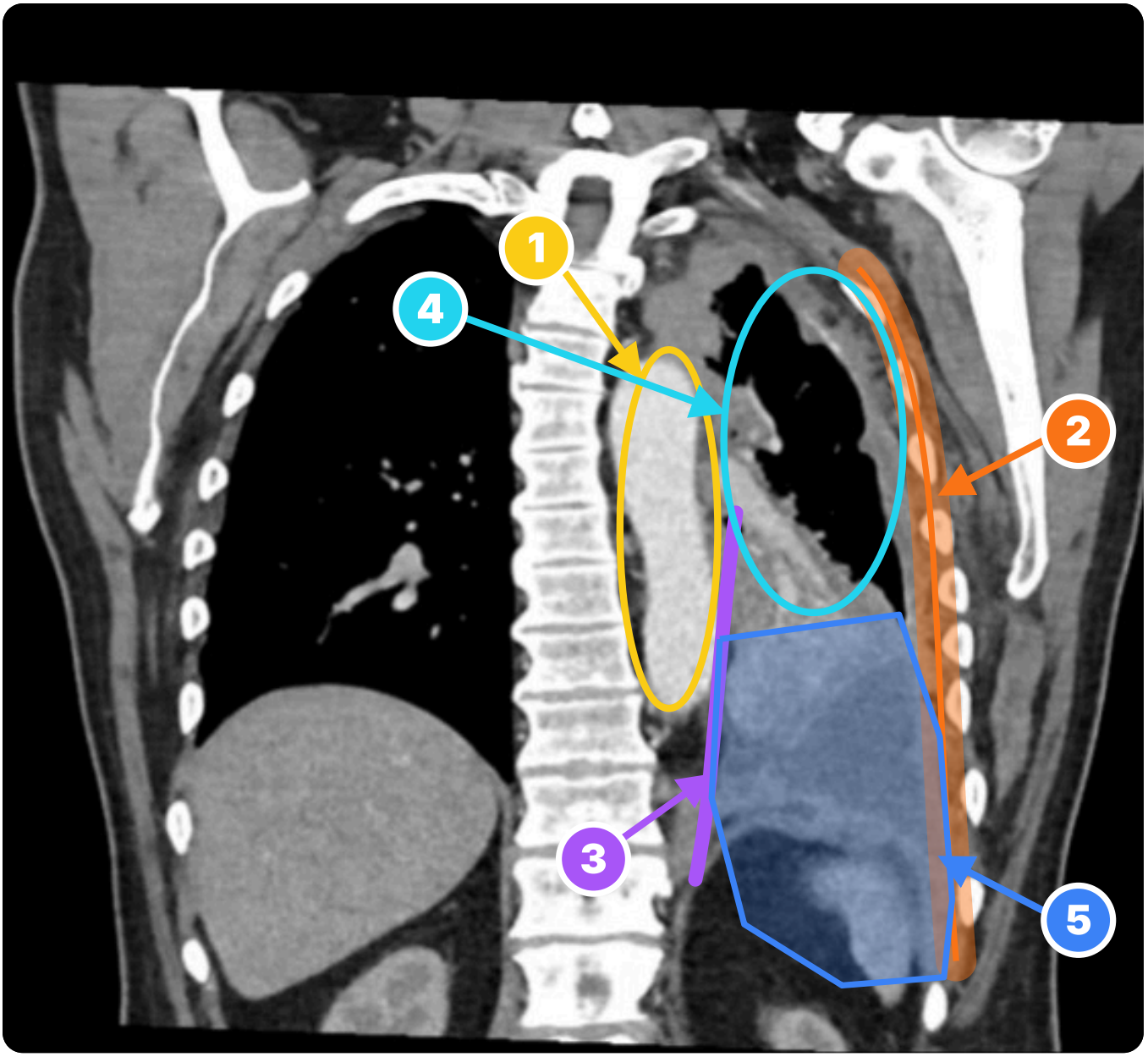
D Une TDM très évocatrice associée à une exposition ancienne à l'amiante permet de retenir définitivement le diagnostic.

FAUX : L'imagerie ne suffit jamais : le diagnostic de certitude est HISTOLOGIQUE (biopsies pleurales avec immunohistochimie). Il conditionne le sous-type, le traitement et le dossier de maladie professionnelle.

Réponses justes : B, C

À retenir : Le scanner injecté oriente, il ne prouve pas. Diagnostic = biopsie + immunohistochimie.

LECTURE DU SCANNER (RECONSTRUCTION CORONALE)



1 **Aorte descendante rehaussée** : TDM **injectée**.

2 **Épaississement pleural gauche** continu de l'apex à la base, irrégulier et nodulaire : plèvre « en cuirasse ».

3 **Atteinte de la plèvre médiastinale** (versant interne).

4 **Poumon gauche rétracté**, bien plus petit que le droit : perte de volume de l'hémithorax.

5 **Masse pleurale basale et épanchement** comblant la base gauche.

6 **Signes d'exposition à l'amiante associés** : plaques pleurales (parfois calcifiées), inconstantes — à rechercher sur l'ensemble des coupes.

Références : Leung A.N. et al., AJR 1990 · Husain A.N. et al., Arch Pathol Lab Med 2018 (IMIG).

QCM 4 / 10 · CYTOLOGIE PLEURALE

La ponction pleurale retrouve un **exsudat séro-hématique**. La cytologie est **négative**.

Devant cet épanchement séro-hématique exsudatif avec une cytologie négative, que peut-on dire de la rentabilité de la cytologie dans le mésothéliome pleural ?

A La cytologie est toujours positive dans le type épithélioïde, ce qui élimine le diagnostic.

FAUX : Doublement faux : la cytologie n'est jamais « toujours positive » (même dans la forme épithélioïde, la mieux détectée), et une cytologie positive ne pourrait de toute façon pas « éliminer » le diagnostic.

B La cytologie du liquide pleural a une faible sensibilité (< 30–50 %) dans le mésothéliome, rendant la biopsie indispensable.

VRAI : La sensibilité de la cytologie pour le mésothéliome est faible (de l'ordre de 30 %, très variable selon les séries, quasi nulle dans la forme sarcomatoïde). Une cytologie négative n'élimine rien : les biopsies pleurales sont indispensables.

C Les cellules mésothéliales malignes ressemblent fortement à des cellules mésothéliales réactionnelles.

VRAI : C'est la principale limite de la cytologie : dans un liquide inflammatoire, les cellules mésothéliales réactionnelles sont atypiques et ressemblent aux cellules malignes. Sans architecture tissulaire (invasion du tissu adipeux), la distinction est très difficile.

D La cytologie négative prouve qu'il s'agit d'une pathologie bénigne liée à l'amiante (plaques pleurales).

FAUX : Les plaques pleurales ne donnent pas d'épanchement, et une cytologie négative ne prouve pas la bénignité. La pleurésie asbestosique bénigne est un diagnostic d'élimination, retenu seulement après une histologie négative et un suivi prolongé.

E La cytologie du liquide pleural est considérée comme insuffisante pour exclure ou affirmer un mésothéliome pleural.

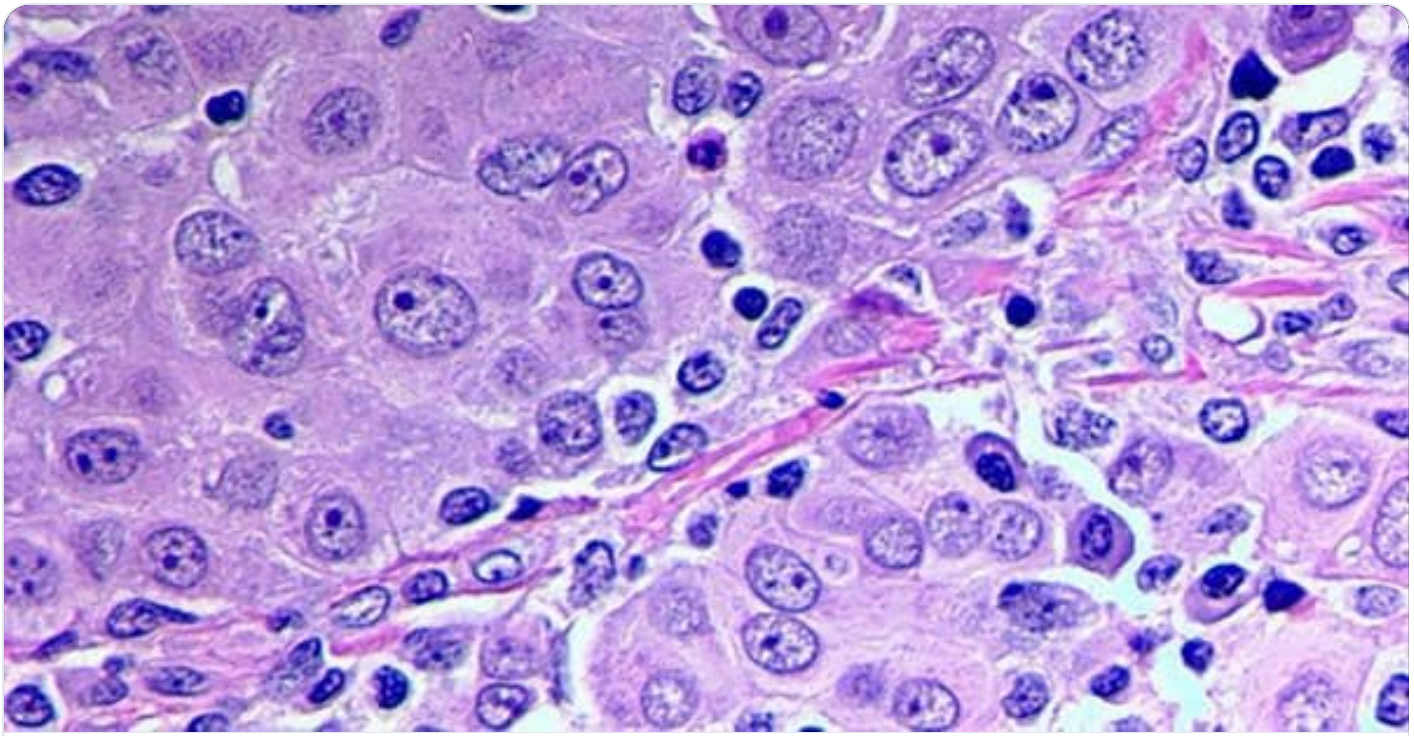
VRAI : Ni pour exclure (faible sensibilité), ni pour affirmer (confusion avec les cellules réactionnelles) : les recommandations exigent une confirmation histologique sur biopsies pleurales, avec immunohistochimie.

Réponses justes : B, C, E
À retenir : Cytologie négative ≠ absence de cancer. Devant une suspicion de mésothéliome : biopsies pleurales.

Références : Scherpereel A. et al., Eur Respir J 2020 · Husain A.N. et al., Arch Pathol Lab Med 2018.

QCM 5 / 10 · BIOPSIE ET ANATOMOPATHOLOGIE

Une **biopsie pleurale thoracoscopique** confirme un **mésothéliome malin pleural de type épithélioïde**.



Mésothéliome pleural malin, type épithélioïde (coloration HES)

Concernant la biopsie et l'examen anatomopathologique, quelles propositions sont exactes ?

A La biopsie pour mésothéliome est réalisée à l'aveugle à l'aiguille de trocart.

FAUX : La biopsie à l'aveugle (aiguille d'Abrams ou de Castelain) a une rentabilité faible, car l'atteinte est hétérogène. On recommande des biopsies sous contrôle de la vue, par thoracoscopie (médicale ou chirurgicale), multiples et profondes ; à défaut, des biopsies guidées par l'imagerie.

B Les prélèvements cytologiques (liquide pleural) seuls sont insuffisants pour affirmer le diagnostic.

VRAI : La cytologie ne permet ni d'apprécier l'invasion ni de distinguer de façon fiable des cellules réactionnelles : le diagnostic repose sur l'histologie avec immunohistochimie.

C Le mésothéliome épithélioïde est le type le plus fréquent (50 à 80 % des cas) ; il présente le pronostic le plus favorable.

VRAI : La forme épithélioïde est la plus fréquente et celle dont la survie est la meilleure ; les formes biphasique puis sarcomatoïde ont un pronostic plus sombre.

D Une prolifération tumorale à différenciation épithélioïde à l'histologie permet de distinguer un mésothéliome épithélioïde d'un adénocarcinome pulmonaire lorsque le prélèvement est suffisamment représentatif.

FAUX : La morphologie seule ne suffit pas : les deux tumeurs peuvent se ressembler. La distinction repose sur l'IMMUNOHISTOCHIMIE : marqueurs mésothéliaux positifs (calrétinine, WT1, CK5/6, D2-40) et marqueurs carcinomateux négatifs (TTF-1, napsine A, CEA...).

E L'examen anatomopathologique est indispensable et obligatoire pour la reconnaissance en maladie professionnelle d'un mésothéliome.

VRAI : Pour un cancer, le diagnostic n'est certain qu'avec l'histologie : c'est elle qui fonde le certificat médical initial (« mésothéliome confirmé par examen anatomopathologique ») et l'examen du dossier par le médecin-conseil.

Réponses justes : B, C, E

À retenir : Diagnostic = biopsies pleurales sous thoracoscopie + histologie avec

immunohistochimie. Épithélioïde = forme la plus fréquente et de meilleur pronostic.

Références : Husain A.N. et al., Arch Pathol Lab Med 2018 (IMIG) · Classification OMS 2021 · Scherpereel A. et al., Eur Respir J 2020.

QCM 6 / 10 · ENQUÊTE PROFESSIONNELLE — TABLEAU

Enquête professionnelle et situation médico-légale

Le patient a exercé comme calorifugeur de 1978 à 2003 dans plusieurs entreprises de maintenance industrielle. Ses tâches comprenaient la découpe, la pose et le retrait d'anciens isolants thermiques. Il rapporte des travaux poussiéreux, parfois en espace confiné, une ventilation insuffisante et une utilisation irrégulière des protections respiratoires.

Les archives professionnelles sont incomplètes. Deux anciens collègues confirment des conditions de travail similaires. Aucune mesure individuelle historique de concentration en fibres n'est disponible.



Calorifuges anciens dégradés sur des tuyauteries : le type de matériau isolant manipulé par un calorifugeur

Quels raisonnements sont appropriés dans le cadre réglementaire algérien ?

A Le tableau n° 31 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante est celui à examiner pour le mésothéliome pleural.

FAUX : Le mésothéliome relève du TABLEAU N° 30 (« affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante »). Viser le bon tableau est la première condition de recevabilité du dossier.

B La liste des travaux du tableau est indicative et les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d'exposition doivent être respectées.

VRAI : Dans le tableau n° 30, la liste des travaux est INDICATIVE : d'autres travaux exposant réellement à l'amiante peuvent être retenus. En revanche, les conditions fixées par le tableau (délai de prise en charge et, lorsqu'elle est prévue, durée minimale d'exposition) s'appliquent strictement.

C Le délai de prise en charge de 30 ans correspond à la durée minimale d'exposition professionnelle à l'amiante devant être démontrée pour permettre la reconnaissance.

FAUX : Confusion classique : le délai de prise en charge est le délai MAXIMAL entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale de la maladie. Ce n'est pas une durée d'exposition à atteindre.

D La désignation de la maladie et le respect du délai de prise en charge ne dispensent pas de vérifier les autres conditions du tableau, notamment celles relatives aux travaux susceptibles de provoquer l'affection.

VRAI : La présomption d'origine n'est acquise que si TOUTES les conditions sont réunies : maladie désignée, délai respecté ET exposition au risque lors de travaux susceptibles de provoquer l'affection.

E L'absence de mesures individuelles historiques de concentration en fibres n'exclut pas la reconnaissance de la maladie professionnelle.

VRAI : Aucune métrologie rétrospective n'est exigée : l'exposition se démontre par le parcours professionnel (certificats de travail, relevé de carrière), la nature des tâches et les témoignages.

Réponses justes : B, D, E

À retenir : Tableau n° 30. Délai de prise en charge de 30 ans = délai maximal entre fin d'exposition et constatation, pas une durée d'exposition. Liste des travaux indicative.

Tableau N° 30 : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante

DÉSIGNATION DES MALADIES	DPC	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
1) Asbestose : – Fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. – *Complications* : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.	**15 ans**	**Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :** • Extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. • Manipulation et utilisation de l'amiante brut. • Manipulation, application, destruction et élimination de produits d'amiante ou à base d'amiante : amiante projetée, calorifugeage au moyen de produits d'amiante, maintenance et entretien de matériels, démolition. • Déflocage.
2) Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : – pleurésie exsudative ; – plaques pleurales ± calcifiées bilatérales, pariétales, diaphragmatiques ou médiastinales ; – plaques péricardiques ; – épaississements pleuraux avec ou sans irrégularités diaphragmatiques.	**15 ans**	
3) Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.	**30 ans**	
4) Autres tumeurs pleurales primitives.	**30 ans**	
5) Cancers broncho-pulmonaires primitifs.	**30 ans**	

RÉFÉRENCE AU TABLEAU DES MALADIES PROFESSIONNELLES

Cette affection est reconnue comme maladie professionnelle au titre du **Tableau n° 30** des maladies professionnelles : « *Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante* ».

Ce tableau comprend : asbestose, lésions pleurales bénignes, **mésothéliome malin primitif**, autres tumeurs pleurales primitives, cancer bronchopulmonaire.

Délai de prise en charge prévu par le tableau : 30 ans.

Conditions constatées :

- l'exposition professionnelle chronique aux poussières d'amiante est établie ;
- le diagnostic de mésothéliome malin est médicalement et histologiquement confirmé.

Ainsi, il s'agit d'une **MALADIE PROFESSIONNELLE RECONNUE**

(et non d'une simple maladie à caractère professionnel)

Références : Loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 · Tableau n° 30 des maladies professionnelles.

QCM 7 / 10 · CHRONOLOGIE ET DÉLAIS

Chronologie

1978	Première exposition suspectée
2003	Dernière exposition suspectée
Juin 2026	Début des symptômes
18 sept. 2026	Première constatation médicale documentée
2 oct. 2026	Confirmation histologique

Situation actuelle : diagnostic confirmé, origine professionnelle suspectée, reconnaissance par la CNAS non encore prononcée.

Concernant les dates du dossier, quelles propositions sont exactes ?

A Si les premiers symptômes remontent à juin 2026, le délai réglementaire doit obligatoirement être calculé à partir de cette date, même si aucune constatation médicale n'a alors été réalisée.

FAUX : Le point de départ retenu est la date de la PREMIÈRE CONSTATATION MÉDICALE (ici le 18/09/2026, premier document médical objectivant l'atteinte), et non le début des symptômes rapporté par le patient.

B Le délai de prise en charge prévu par un tableau professionnel se calcule en tenant compte de la période réglementaire définie après la cessation de l'exposition.

VRAI : Le délai de prise en charge est la période maximale, fixée par le tableau, qui sépare la CESSATION de l'exposition de la première constatation médicale.

C Une date de cessation d'exposition établie en 2003 et une première constatation médicale retenue en septembre 2026 correspondent à un intervalle d'environ 23 ans ; cet intervalle est inférieur à 30 ans, donc le délai de prise en charge n'est pas respecté.

FAUX : Le calcul est juste (≈ 23 ans) mais la conclusion est inversée : 23 ans < 30 ans signifie que la maladie a été constatée AVANT l'expiration du délai maximal → le délai est RESPECTÉ.

D Les dates de cessation d'exposition, de première constatation médicale et de diagnostic doivent être documentées avec précision.

VRAI : Chacune a un rôle propre : la fin d'exposition ouvre le délai, la première constatation médicale le ferme, la confirmation histologique fonde le diagnostic. Une imprécision peut faire rejeter le dossier.

E Aucune durée minimale d'exposition n'est légalement exigée dans le tableau pour le mésothéliome.

VRAI : Le tableau n° 30 fixe pour le mésothéliome un délai de prise en charge (30 ans), mais aucune durée minimale d'exposition. Une exposition même brève peut suffire, ce qui est cohérent avec l'absence de seuil connu.

Réponses justes : B, D, E
À retenir : Délai de prise en charge = maximum entre fin d'exposition et première constatation médicale. Ici ≈ 23 ans < 30 ans : délai respecté.

Références : Loi n° 83-13 du 2 juillet 1983.

QCM 8 / 10 · CERTIFICAT MÉDICAL

Un **certificat de maladie professionnelle** a été établi.



وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
CNAS
Accidents du Travail et Maladies Professionnelles

Visa de la Caisse

Référence : .....

N° Immatriculation
07 85 02 123456 78 001

CERTIFICAT MÉDICAL
INITIAL OU DE PROLONGATION

☑ MALADIE PROFESSIONNELLE

☐ MALADIE A CARACTÈRE PROFESSIONNELLE
(voir tableau des maladies professionnelles)

(1) Mettre une croix dans la case correspondante (adresser à la caisse dont un (01) au service de prévention. 1er troisième (3ème), exemplaire à remettre à l'intéressé.

Tableau N° 30 des maladies professionnelles

Je soussigné, Docteur : BABAAISSA Zakaria
Grade et spécialité : Médecin spécialiste en Médecine du Travail
Adresse professionnelle : Service de Médecine du Travail
Etablissement Hospitalier Universitaire de Laghouat
Certifie avoir examiné M. : B. Abdekader
Date de naissance : 06 / 10 / 1958 à : Laghouat
Employé(e) actuellement par (nom ou raison Sociale de l'employeur) : Sans emploi depuis 2003 (ancien salarié)
En qualité de : Ancien calorifugeur au poste de : Travaux d'isolation thermique et de calorifugeage
Nature du travail effectué au moment de l'exposition au risque :
Manipulation et retrait d'isolants susceptibles de contenir de l'amiante, avec exposition professionnelle aux poussières d'amiante.
Constat et certifie ce qui suit (2) :
Mésothéliome pleural malin primitif confirmé par examen anatomopathologique, dans un contexte d'exposition professionnelle ancienne à l'amiante.
Son état nécessite un arrêt de travail de : ____ jours,
à compter du : __ / ____
et présente une incapacité permanente de : ___ %.

Fait à Laghouat, le 25/10/2026
Cachet et Signature du Médecin

Dr BABAAISSA Zakaria
Médecin spécialiste en Médecine du Travail
Service de Médecine du Travail
Etablissement Hospitalier Universitaire de Laghouat

(1) Mettre une croix dans la case correspondante.
(2) Fournir toutes indications utiles sur la maladie et ses symptômes. Indiquer si possible la durée de la maladie et éventuellement spécifier si elle doit entraîner une incapacité de travail.

tableau n° 30 des maladies professionnelles

Certificat médical initial — CNAS

Un certificat de maladie professionnelle a été établi. Cochez les réponses justes :

A C'est un certificat de constatation de la maladie établi en deux exemplaires.

FAUX : Le piège est le nombre : le certificat médical initial (CMI) est établi en TROIS exemplaires, et non deux. Deux sont adressés à la caisse (CNAS), dont un est transmis au service de prévention ; le troisième est remis à l'intéressé (la victime). C'est d'ailleurs ce que rappelle le renvoi (1) du formulaire CNAS.

B C'est un certificat médical initial (CMI) de maladie à caractère professionnel.

FAUX : La case cochée est « MALADIE PROFESSIONNELLE » : l'affection figure au tableau n° 30 et bénéficie de la présomption d'origine. La « maladie à caractère professionnel » désigne une affection NON inscrite dans un tableau.

C Il contient l'identité du patient, les coordonnées du médecin, la description détaillée de l'affection ainsi que la durée éventuelle de l'arrêt de travail.

VRAI : C'est la structure du formulaire : identité et immatriculation de l'assuré, nom, qualité et adresse du médecin, nature du travail exposant, description de l'affection, durée éventuelle de l'arrêt et taux d'incapacité, date, cachet et signature.

D Il sert à décrire précisément l'état de santé du patient et la date de la première constatation médicale, servant de base obligatoire pour l'examen du dossier par le médecin-conseil.

VRAI : Le certificat fixe la description médicale de l'affection et la date de première constatation ; le médecin-conseil de la CNAS s'appuie sur ce document pour vérifier les conditions du tableau.

E Il peut être rédigé par le médecin traitant, un médecin spécialiste, un praticien hospitalier ou le médecin du travail.

VRAI : Tout médecin peut établir le certificat médical initial. Le croire réservé à un spécialiste « agréé » retarde inutilement les démarches du patient.

Réponses justes : C, D, E

À retenir : CMI de MALADIE PROFESSIONNELLE (tableau n° 30) : document descriptif, rédigé par tout médecin, base du dossier examiné par le médecin-conseil.

Références : Loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 · Formulaire CNAS « Certificat médical initial ou de prolongation ».

QCM 9 / 10 · PREUVE DE L'EXPOSITION

L'exposition professionnelle paraît plausible, mais certaines **archives sont manquantes**.

Quelles propositions sont exactes ?

A Si le patient a déjà passé des scanners thoraciques montrant des plaques pleurales calcifiées, ces dernières constituent une « signature » radiologique incontestable d'une exposition passée à l'amiante.

VRAI : Les plaques pleurales calcifiées, surtout bilatérales et siégeant sur la plèvre pariétale ou diaphragmatique, sont un marqueur d'exposition à l'amiante quasi pathognomonique. Le scanner est l'examen de référence (bien plus sensible que la radiographie). Elles apparaissent après une latence de plus de 20 ans, sont bénignes et non précancéreuses, mais certifient la réalité d'un contact antérieur avec l'amiante : un argument précieux pour le dossier médico-légal. À distinguer des calcifications pleurales unilatérales séquellaires (tuberculose, hémothorax).

B Les témoignages de collègues peuvent compléter l'enquête, sans dispenser de l'examen des autres éléments disponibles.

VRAI : Les témoignages sont une pièce recevable, à croiser avec les autres éléments : certificats de travail, relevé de carrière, fiches de poste, nature des installations.

C Il n'est pas obligatoire de prouver scientifiquement la présence de fibres. Il faut prouver l'exercice de la profession et la nature des tâches.

VRAI : Le système des tableaux n'exige pas la mise en évidence de fibres dans les tissus : il faut établir l'exercice de travaux exposant au risque et leur nature.

D L'existence d'une exposition extraprofessionnelle exclut une origine professionnelle.

FAUX : Une exposition domestique ou environnementale associée n'exclut pas l'origine professionnelle : si les conditions du tableau sont réunies, la présomption d'origine s'applique.

Réponses justes : A, B, C
À retenir : On prouve le travail exposant, pas la fibre. Les plaques pleurales calcifiées bilatérales sont la signature radiologique de l'exposition.

Références : Loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 · Tableau n° 30.

QCM 10 / 10 · PRÉVENTION

L'enquête révèle que d'autres travailleurs ont effectué des travaux comparables sur les mêmes installations.

Quelles propositions sont exactes ?

A Le port d'un appareil de protection respiratoire adapté et la surveillance médicale périodique constituent les principales mesures de prévention primaire, puisqu'ils permettent d'éviter l'apparition de la maladie.

FAUX : La prévention primaire empêche l'exposition : d'abord suppression ou substitution (interdiction de l'amiante), puis protection collective, et seulement en dernier recours la protection individuelle. La surveillance médicale ne prévient pas la maladie : elle relève de la prévention SECONDAIRE.

B La traçabilité de l'exposition professionnelle et la surveillance médicale des travailleurs exposés s'inscrivent dans une démarche de prévention secondaire.

VRAI : Le suivi médical des exposés vise un repérage et une prise en charge précoces : prévention secondaire. La traçabilité de l'exposition le rend possible.

C Le reclassement professionnel d'un travailleur atteint d'un mésothéliome pleural malin constitue une mesure de prévention secondaire visant à dépister précocement les complications.

FAUX : Chez un travailleur déjà malade, reclassement et aménagement du poste visent à limiter les conséquences de la maladie : c'est de la prévention TERTIAIRE, pas un dépistage.

D La déclaration de la maladie professionnelle, l'accompagnement médico-social et l'indemnisation d'un travailleur atteint relèvent principalement de la prévention tertiaire.

VRAI : Ces mesures limitent les conséquences sociales, fonctionnelles et financières de la maladie : prévention tertiaire et réparation.

E L’interdiction de l’importation et de la commercialisation de toutes les variétés de fibres d’amiante a été finalisée par le décret exécutif n° 09-321 en octobre 2009.

VRAI : Le décret exécutif n° 09-321 d’octobre 2009, modifiant le décret n° 99-95 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante, a interdit l’importation, la fabrication et la commercialisation de toutes les variétés de fibres d’amiante. L’amiante déjà en place reste un risque (maintenance, démolition, désamiantage).

Réponses justes : B, D, E

À retenir : Primaire = éviter l’exposition · Secondaire = dépister · Tertiaire = limiter les conséquences.

Références : Décret exécutif n° 99-95 du 19 avril 1999 · Décret exécutif n° 09-321 d’octobre 2009.

Ce qu'il faut retenir

Un **mésothéliome pleural malin** probablement lié à une **exposition professionnelle ancienne à l'amiante** chez un ancien calorifugeur. Voici les messages à retenir :

🔍 **Pleurésie de l'adulte exposé : penser large**

Devant un épanchement pleural unilatéral avec altération de l'état général chez un ancien exposé à l'amiante, on évoque le mésothéliome, le cancer bronchopulmonaire, la pleurésie métastatique et, en Algérie, la tuberculose pleurale. L'insuffisance cardiaque n'explique ni la douleur ni l'amaigrissement.

🧫 **Cytologie négative ≠ pas de cancer**

La cytologie pleurale a une faible sensibilité dans le mésothéliome (de l'ordre de 30 %). Le diagnostic de certitude est histologique : biopsies pleurales multiples, idéalement par thoracoscopie, avec immunohistochimie.

🫁 **Mésothéliome ≠ cancer bronchopulmonaire**

Le tabac n'est pas un facteur de risque du mésothéliome : il n'entre pas dans l'attribution causale. La synergie tabac × amiante concerne le cancer bronchopulmonaire.

📅 **Début des symptômes ≠ première constatation médicale**

Le point de départ retenu pour le délai est la première constatation médicale documentée (ici le 18 septembre 2026), et non la date de début des symptômes rapportée par le patient.

⏳ **Délai de prise en charge de 30 ans ≠ durée d'exposition**

Le tableau n° 30 fixe un délai MAXIMAL de 30 ans entre la fin de l'exposition et la première constatation médicale. Ici, 2003 → 2026 ≈ 23 ans : le délai est respecté.

📂 **Pas de mesures, pas d'asbestose ≠ pas d'origine professionnelle**

On prouve l'exercice de travaux exposants (certificats de travail, témoignages, nature des tâches), pas la présence de fibres. L'absence de métrologie historique ou d'asbestose n'exclut pas la reconnaissance.

📝 **Le certificat médical initial**

Certificat de MALADIE PROFESSIONNELLE, établi en trois exemplaires (deux pour la CNAS dont un pour la prévention, un pour la victime). Il peut être rédigé par tout médecin et sert de base au médecin-conseil.

🛡️ **Trois niveaux de prévention**

Primaire : supprimer ou réduire l’exposition (interdiction de l’amiante, protection collective). Secondaire : dépistage et surveillance médicale des exposés. Tertiaire : limiter les conséquences (déclaration, reclassement, indemnisation).